

加强住院患者营养素和药物相互作用的宣教

李燕玲

宁洱县中医医院 云南 宁洱 665100

【摘要】目的:使患者了解药物与营养素的相互作用,让患者正确用药以达到治疗目的,而又不发生与营养素相互影响的各类问题。方法:对住院患者进行药物和营养素相互影响的个人专宣教。结果:药物和营养素在体内不发生影响彼此的作用和效应。结论:加强用药后药物与营养素相互作用的监护,为患者做好相关的饮食和药物宣教。

【关键词】药物 营养素 饮食和用药指导

【中图分类号】R151.4+1

【文献标识码】B

【文章编号】1009-6019(2014)09-0321-01

在临床护理中,护士对住院患者所进行的饮食和药物宣教都比较笼统,往往只注重药物本身治疗作用或毒副作用。而饮食宣教只是饮食宜忌的一般内容,宣教时很少涉及饮食营养素和药物的相互作用,以及它们在体内影响彼此的作用。因此,本人提出一点常见的药物与营养素在体内相互作用现象,让护士在进行药物和营养素宣教时,引起关于这方面的重视,使宣教内容具有根据性和科学性。

1. 药物和营养素的相互作用的定义:是指药物进入人体后,除发生治疗作用和毒副作用外,还对人体营养状况发生某些作用,如妨碍或促进营养素的吸收,抵抗某些营养素的生物学功能,改变人体对营养素的需要量等。另一方面人体营养状况和膳食中的营养素也会对进入人体的药物发生某些作用,如影响药物的吸收与代谢,特殊情况下还可引起药物的毒性增大或使药物失效,这种营养素与药物在体内发生影响彼此的作用和效应现象而称之。

2. 营养素和其他食物成份对药物的影响

2.1 营养素和食物其他成份对药物吸收的影响

对住院患者进行宣教时,向患者讲明膳食成份既可促进也可阻碍或减缓药物的吸收,如富含钙、镁、锌、铁等矿物质的牛奶及其他膳食,其矿物质可与四环素类抗生素结合成不溶性物质而妨碍药物吸收,降低疗效。另外,膳食纤维也可与某些药物结合而减少其吸收,嘱患者在服用这些药物时少食膳食纤维。又如膳食性脂肪可促进脂溶性维生素吸收,在服用脂溶性维生素时可适当增加膳食脂肪量。

2.2 饭前后服药的治疗效果

护士在指导患者服药时,应掌握药物在胃内停留时间长短或分解快慢及以胃液反应情况而决定饭前服还是饭后服,如左旋多巴、青霉素、氨茶碱等多数药物饭前服时吸收快,药效高,因为这些药物在胃内停留时间越长,有效成份分解破坏越多,然而另一些药物如心得安、胍苯哒嗪等应在饭后服用,这些药物在胃内停留时间长,溶解到胃里药物成份就越多,其生物利用率就越高。另外,胃酸酸度也易影响某些药物的吸收,如青霉素、阿斯匹林、红霉素等药物在酸性环境中易破坏,所以在服药时应忌服酸性食物,以免药效降低。其次,植酸也易与药物结合影响药物吸收,例如,茶叶中鞣酸易与黄连素、硫酸亚铁、四环素等药物结合成不溶性物质。因此如贫血患者应忌饮茶。

3. 营养素对药物代谢的影响

研究表明,药物在肝脏和其他组织代谢主要是氧化过程,膳食营养素主要影响氧化反应,此反应可活化某些药物,也可灭活某些药物,例如,在进食含较多十字花科蔬菜如卷心菜、甘蓝时,能通过所含某些诱导成份加速氨茶碱、非那西丁等药物的清除。另外,洋地黄类药物的强心作用是抑制钠-钾泵代谢而发生作用,如长期摄钾不足或失钾过多患者易发生洋

地黄中毒,如长期腹泻患者应特别注意。饮酒对药物代谢影响更突出,长期饮酒可增强药物的毒副作用。因此,在服药期间,指导患者最好不饮酒,尤其在用镇痛药、麻醉药、抗惊厥药、镇静剂的患者如饮酒,可使其药物毒性增大而发生意外。

4. 药物对营养素的影响

药物常影响食欲,有些使食欲减退,有些使食欲增加。药物还影响食物消化吸收及营养素的代谢和排泄。因此,护士应正确安排患者服药和进食。

4.1 有些药物易使人厌食或增加食欲

据研究发现,盐酸去甲麻黄碱等药物可作用于中枢神经系统,使其释放一些使人产生饱腹感的神经递质。从而使人产生厌食。而另一些药物,则可增加食欲,如肾上腺皮质激素类药物,安定、碳酸锂等常使人感到饥饿,因而增加食欲。

4.2 药物对营养素吸收的影响^[1]。有些药物对营养素的吸收有阻碍作用,如氢氧化铝可与膳食中的磷酸根结合,形成不溶性磷酸铝而使磷不能吸收,使体缺乏磷,另外,抗酸药不利于硫酸素的稳定,如长期服用,易导致硫酸素缺乏。导泻药可缩短食物在肠道内停留时间,易影响碳水化合物、蛋白质、钙、钾等营养素的消化吸收,所以长期便秘患者应采取正确的缓解便秘的方法,不宜长期使用导泻药物。另外,长期使用秋水仙碱治疗痛风患者,其对肠道转运机制有影响,可使氨基酸、脂肪酸、钠钾等营养素吸收减少,应常监测及补充。

4.3 药物对营养素代谢的影响。药物研究时发现孕妇如服用苯妥因钠或巴比妥类药物可引起叶酸、维生素K、B12缺乏,导致新生儿畸形或凝血障碍,因此,孕妇用药更应该特别注意。另外,长期服用抗结核药异烟肼时,应同时服用维生素B6,因异烟肼可与维生素B6结合而使其失去活性,造成维生素B6缺乏和周围神经炎。此外药物对营养素的排泄也有影响,如外伤患者在使用肾上腺皮质激素时,可增加尿中氮、钾、锌的排出,延缓伤口愈合,应额外补充这些营养素来改善症状,利尿药也有此作用,应用时需监测电解质平衡状况。

5. 讨论

药物和营养素是住院或长期用药患者康复的关键,一般情况下,其相互作用不易被发现,短期用药也很少引起营养素问题,但特殊患者如老人、孕妇、儿童对药物的毒副作用更敏感,护士在药物指导时应更注意正确指导,加强用药后药物与营养素相互作用的监护,护士更应该不断加强药理知识的学习,才能为患者做好相关的饮食和药物宣教。

参考文献

[1] 郭文卫,营养学[M].北京:北京科学出版社,2002:12.

门诊药师拒发 121 例不合理处方分析

陈影波

浙江省嘉兴市妇幼保健院药剂科 浙江 嘉兴 314000

【摘要】目的:探讨药师在门诊药房审核处方时对合理用药产生的意义。方法:对我院2014年1-5月门诊药师拒发的处方进行统计分析。结果:药师拒发不合理处方共121例,差错原因主要涉及用法用量不适宜、遴选药品不适宜等方面。结论:通过药师审核并对不合理处方进行干预,可有效减少或防范处方差错,保障临床用药安全、合理、有效。

【关键词】药师;不合理处方;差错

【中图分类号】R952

【文献标识码】B

【文章编号】1009-6019(2014)09-0321-02

随着医药卫生事业的发展,门诊药师的职责从简单的配方调剂逐渐向以患者为中心的药学技术服务型转变,门诊药师在审核处方、调配处方的同时,对医师处方进行甄别,对患者合理用药予以指导并提供咨询服务,使患者安全、有效、合理、经济的用药,这也是药学服务的真正目的^[1]。本文通过对我院门诊药师拒发的不合理处方进行统计分析,探讨药师对合理用药产生的意义。

1 资料与方法

1.1 资料

数据来源于我院门诊药房日常审核处方时发现问题、及时退回并记录在案的不合理处方记录表。

1.2 方法

选取我院门诊药房2014年1-5月当场退回并记录在案的不合理处方,对其进行整理、归纳,并对相关数据进行统计分析。

2 结果与讨论

2.1 统计结果

2014年1-5月,我院门诊药师经审核发现并退回不合理处方共计